

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒膀胱輸尿管逆流 Vesicoureteral Reflux, VUR				
編號	A31000-Q03-W-N13	制定者	R10 陳倩芳	公布日期	100 年 08 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 2.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解小兒膀胱輸尿管逆流的定義、症狀、診斷方法、檢查、分級、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，提供更適切之照護能力及服務品質。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

（一）定義

膀胱輸尿管逆流為小兒泌尿系統常見疾病。其成因為膀胱輸尿管交接處異常，解小便時尿液會回流到輸尿管或腎臟，引起尿路感染，並破壞腎臟。少部份病人因為神經性膀胱或其他構造上的異常，而引起逆流，稱為次發性膀胱輸尿管逆流。

（二）症狀

- 1.發燒，因尿路感染引起。
- 2.部份病人沒有症狀，但在檢查時發現腎臟萎縮或水腎。

（三）診斷方法

尿路感染時，尿液檢查可見白血球及細菌。膀胱攝影可顯示逆流程度，一般依程度可分為五級，核醫腎臟掃描可顯示腎受損程度。

（四）檢查：

1. 膀胱尿道攝影(Voiding cystourethrogram, VCUG)：這種放射線檢查是把顯影劑以導尿管方式注入膀胱內部，等待病人排尿時予以照相，便可觀察內部逆流情形。膀胱尿道攝影一般可安排在抗生素治療四至六週後，此時膀胱的發炎狀態

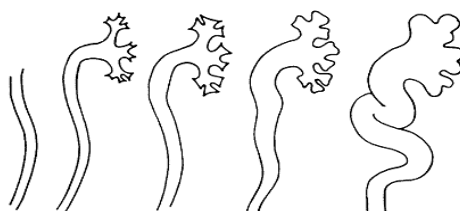
主題名稱	小兒膀胱輸尿管逆流	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N13	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	2/7

已消退，檢查較安全，也較準確。膀胱尿道攝影也可診斷出是否有雙套集尿系統或憩室等膀胱之異常。

2. 腎臟超音波：其優點不具有侵襲性，可以看見腎臟皮質的形狀，對於診斷及追蹤腎臟結疤與評估功能上，有相當的效率及準確度，此外，也可發現有無水腎或輸尿管擴大情形，但逆流程度不嚴重者，其檢查結果可能為正常，所以超音波檢查僅是很好的篩檢，並不是診斷膀胱輸尿管逆流的理想工具。
3. 核子醫學檢查：可以清楚地顯示整個腎臟皮質的形狀，對於診斷及追蹤腎臟結疤與評估功能上，有相當的效率及準確度。
4. 靜脈腎盂攝影術：主要是能顯示出腎臟皮質及泌尿系統的形狀，能夠診斷出腎臟結疤及損傷情形。
5. 核醫解尿性膀胱攝影：優點是輻射量較低，對於膀胱輸尿管逆流的診斷及追蹤相當方便，缺點是無法明確地將逆流的嚴重度分級。
6. 膀胱功能檢查又稱尿動力學檢查：為病人解尿時，可測得知膀胱容量、壓力變化情形、餘尿及尿流速及尿道括約肌的功能等。

（五）分級

臨床上最為重要而實用的分類，為國際分類法(International classification)，依排尿膀胱尿道攝影檢查的表現做為分類的依據，第 1 度為輸尿管僅有部分顯影，但並無輸尿管徑的脹大；第 2 度膀胱輸尿管尿逆流輸尿管已經完全顯影，但並無輸尿管徑的擴大。第 3 度已表現出有腎盂的脹大，但小腎盞穹窿(Minor calyceal fornices)的角度仍保持鈍角；第 4 度膀胱輸尿管尿逆流為合併有明顯的腎盂脹大，而且小腎盞穹窿的角度則已經變為鈍角；第 5 度膀胱輸尿管尿逆流，輸尿管已經有明顯的脹大扭曲，並且表現出嚴重的水腎，如下圖。



主題名稱	小兒膀胱輸尿管逆流	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N13	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	3/7

(六) 常見治療

1. 包括找出膀胱輸尿管逆流的原因，控制感染，避免急性腎盂腎炎的發生，促進正常腎臟的發育以及體格成長，阻止腎臟瘢痕化的進行、腎性高血壓及尿毒症的發生。
2. 輕度逆流（一至二度）可考慮服用抗生素治療及定期檢查。較嚴重的逆流（三度以上）、兩側逆流、腎受損程度嚴重、抗生素治療效果不佳者都應考慮手術。常用的手術為輸尿管重植。
3. 三度、四度膀胱輸尿管逆流的病童治療則未有定論，保守或手術治療皆可。
4. 第五度病童一定沒有自行緩解的機會，因此必須進行手術治療。

(七) 護理問題

1. 發燒／感染。
2. 焦慮感受／對於疾病的治療流程不清楚。
3. 易感染／膀胱輸尿管逆流的術後傷口與引流管留置。
4. 照顧者感到緊張／家屬對病人身上的管路不熟悉。

(八) 護理措施

1. 發燒／感染

- (1) 向病人及其家屬說明體溫上升的原因。
- (2) 教導病人及主要照顧者降低體溫的方法。
- (3) 調整衣物被蓋及提供舒適室溫(24-26°C)並維持通風。
- (4) 病人發燒引起寒顫時，在其四肢覆蓋毛巾保暖。
- (5) 冰枕或冰寶使用。
- (6) 病人流汗時給予擦乾，建議穿棉質衣服保持舒適及乾爽。
- (7) 協助追蹤各項相關之檢驗報告結果。
- (8) 依醫囑給予溫水拭浴（水溫 27-32°C，毛巾沾濕自病人雙側腹股溝、腿內側、膝窩、足跟、擦拭 8 分鐘）。
- (9) 依醫囑給予解熱劑。

主題名稱	小兒膀胱輸尿管逆流	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N13	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	4/7

(10) 每 30 分鐘測量生命徵象至穩定並記錄。

(11) 依醫囑給予靜脈點滴輸液。

(12) 依醫囑給予抗生素注射。

2. 焦慮感受／對於疾病的治療流程不清楚。

(1) 於各項檢查前，告知照顧者應注意的事項，並且儘速告知家屬檢查結果。

(2) 給予照顧者護理指導單張，並且配合口頭衛教說明膀胱輸尿管逆流的治療方式，包括手術方式、治療時間與預後情形。

(3) 鼓勵照顧者詢問有關疾病治療照顧方面的疑問，並且給予回覆。

(4) 提供術後成功的病人家屬給予支持。

3. 易感染／膀胱輸尿管逆流的術後傷口與引流管留置。

(1) 評估及監測生命徵象及血液檢驗值的變化。

(2) 術後評估與觀察傷口是否有紅腫熱痛、滲出液的情形。

(3) 協助指導家屬保持傷口的清潔與完整，並隨時觀察傷口有無紅腫熱痛。

(4) 觀察引流液的性質、量。

(5) 協助醫師進行無菌換藥。

(6) 評估病人每日尿液的顏色、量及是否有沉澱物產生。

(7) 盡早拔除引流管，降低感染情形。

(8) 依醫囑給予抗生素治療。

4. 照顧者感到緊張／家屬對病人身上的管路不熟悉。

(1) 協助家屬認識病童身上的管路，並解釋放置的目的。

(2) 鼓勵家屬參與病童的照顧。

(3) 對於家屬的照顧行為給予正向肯定。

(4) 鼓勵家屬表達照顧方面的問題，並針對疑問進行了解與解決。

(九) 衛教指導

1. 依照病童體重鼓勵多喝水。

(1) 3-10 公斤：100 cc／公斤／天。

主題名稱	小兒膀胱輸尿管逆流	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N13	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	5/7

(2) 10-20 公斤：1000 cc + (體重減 10) × 50 cc / 公斤。

(3) 大於 20 公斤：1500 cc + (體重減 20) × 20 cc / 公斤。

2. 嬰幼兒每 2-4 小時要勤換尿布。

3. 提醒病童解尿，對於幼兒或孩童時期的病童，要避免憋尿。

4. 保持泌尿道口的清潔，例如大便後清潔擦拭方向應由尿道口擦至肛門口（由前至後擦拭），勿來回擦拭，以防止將糞便細菌帶到尿道口。

5. 睡前排尿兩次，以減少餘尿殘留在膀胱內。

6. 配合醫師治療指示定期服藥治療，勿隨便自行停藥及定期追蹤檢查。

（十）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（一）李慈音(2021)・兒童泌尿系統疾病及其護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理（九版，587-626 頁）・台北：華杏。

（二）蔣立琦、蔡綠蓉、黃靜微、邱淑如、毛新春、吳書雅...吳佩玲(2023)・兒童泌尿生殖系統疾病與護理・於黃美智、蔣立琦總校閱，兒科護理學（六版，705-709）・台北：永大。

七、附件

（略）

主題名稱	小兒膀胱輸尿管逆流	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N13	版本	第 2.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.31	1.0	新制定。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	1.1	修改錯字及修正文章順暢度。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	2.1	增修第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	2.2	1.第三項第(四)、(八)目內容刪修。 2.將參考文獻出處呈現於內文中。 3.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	2.3	修訂第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.06	2.4	1.第三項第十目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 2.修訂第六項參考文獻資料。	108 年 06 月 06 日照 護標準組會議通過； 108 年 06 月 12 日護 理長會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.08.06	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	2.5	1.更新第三項第七目護理問題及第八目護理措施。 2.更新第六項文獻參考資料。 3.內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照 護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護 理長會議通過；111 年

